

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 11:31:42

Página 1 de 4

### Información Paciente

**Nombre** : Felipe Andres Millapan Millapan  
**Edad** : 34a 11m 17d  
**Dirección** : Gabriel Gonzalez Videla 1213

**Rut** : 17.782.556-5  
**Fecha Nacto**: 15/03/1988  
**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : A700671  
**Sexo** : Masculino  
**Teléfono** : 9 6806 6885

**N° Epicrisis**  
**343786**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Ingreso** : 27/12/2022 00:05

**Días Estadía**: 67

**Unidad de Egreso** : Medicina Agudos (4tp Piso)

**Fecha Egreso** : 04/03/2023 11:03

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

Nombre: Felipe Millapán Millapán  
RUT: 17782556-5  
Edad: 34 años  
FI CASR: 26/12/22  
FI UCI: 29/12/22  
FI UTIN: 25/01/23  
FI SALA MI: 03/02/23

#### ANTECEDENTES

Médicos: Poli consumo (al menos conocido a Cocaína y PBC), resto desconocido

MOTIVO DE CONSULTA: Compromiso de conciencia

#### Historia de ingreso:

(Datos obtenidos de ficha médica, sin familiares presentes al momento del ingreso).

Paciente con antecedente de policonsumo, desde el 24 de diciembre con abuso de sustancias psicoactivas, encontrado el 27/12 comprometido de conciencia, en glasgow 11, con paresia de brazo derecho y afasia, por lo que es traído a SU CASR.

Ingresa al REA con protección de vía aérea. Se solicita TC Cerebro (26/12) que muestra HSA Fisher IV + vaciamiento ventricular + HIC frontal izquierdo, con aneurisma Comunicante Anterior.

Evaluable por Neurología se observa caída de GCS a 6pts, al EF: Coma, pupilas isocóricas reactivas, hemianopsia derecha por amenaza, reflejo corneal disminuido a derecha, ROC presentes, leve PFC der, localiza con hemicuerpo izquierdo, retira con el derecho (al menos M2), plantar extensor derecho. Se realiza IOT para proteger vía aérea.

Evaluable por NCx, se instala DVE el 27/12, sin incidentes. El mismo 27/12 se realiza angiografía dónde se confirma aneurisma Sacular Comunicante Anterior de 5x4mm de paredes irregulares y se realiza embolización de aneurisma con 3 coils. Sin vasoespismo. Se realiza embolización con 3 coils. Controles con oclusión del aneurisma y permeabilidad de ambas Cerebrales Anteriores. Egres a Recuperación en espera de traslado a UCI. Se realiza TC Control post Angiografía impresiona sin mayores cambios con respectos TC de entrada.

#### DIAGNÓSTICOS DE INGRESO a UPC:

1. HSA Fisher IV WFNS IV-V Aneurismática sacular, con Aneurisma C.Anterior.

Fecha Epicrisis : 04/03/2023 11:31

Página 1 de 4

**Fecha Última Actualización: 04-03-2023 11:31:42**

Página 2 de 4

·Vaciamiento ventricular + HIC frontal izquierdo (27/12/22)  
·Instalación DVE (27/12/22)  
·Angiografía terapéutica 27/12 con 3 coils.  
2. Sepsis foco respiratorio:  
·Obs Neumonía aspirativa v/s NAVM con E. Cloacae (+) CAET.  
3. Antecedentes: Policonsumo  
Evolución durante Hospitalización en UPC:

1) Hemodinamia: Durante estadía en UPC se mantiene con macrohemodinamia estable y perfusión periférica conservada. En contexto de neurocrítico y uso de sedoanalgesia con requerimientos intermitentes de DVA - NAD para meta PAM >90.

2) Ventilatorio: Ingresa en VMI con PaFi >200 durante toda su estadía. Cursa con interurrencias infecciosas asociadas a fluctuación de gasometría. Se mantiene inicialmente con sedoanalgesia (Propo/Fenta/Mida) para SAS 1 como neuroprotección. Dificultad para superficializar sedación, probablemente secundario a policonsumo y múltiples HITs infecciosos. Evoluciona con destete prolongado, sin criterios de PVE, por lo que finalmente se decide TQT percutánea el 17/01 sin incidentes. Evoluciona de forma favorable, tolerando soporte CPAP y titulación PEEP/PS a la baja. Con buena tolerancia a filtro desde el 20/01 con estabilidad gasométrica y buena mecánica ventilatoria, en rehabilitación kinésica y fonoaudiológica.

3) Neurológico: Paciente ingresa en contexto de HSA Fisher IV por aneurisma Co.A, HIC frontal, con vaciamiento ventricular. DVE el 27/12/22. Se toman medidas de neuroprotección con PAM 90-100, hipernatremia permisiva 145-150, FAE profiláctico, Nimodipino x 21 días, además de normotermia y euglicemia.

Cursó con vasoespasmo y HTIC, por lo que el 02/01 se instala Captor de PIC y se realiza angiografía con angioplastia química de vasoespasmo (realizada el 02 y 03/01). Posteriormente con AngioTC de control (03/01) con aumento de desviación de línea media por lo que va a craniectomía descompresiva de urgencia, sin incidentes. Se re-instala DVE el 05/01, TC de cerebro de control (06/01) con extensos infartos en territorio de ambas ACAs y ACM izquierda asociado a gran edema cerebral y herniación trans-craniectomía, leve dilatación ventricular, DVE in situ. Evoluciona con débitos estacionarios de DVE, 0 cm de CAE, con TC de control sin cambios. Último estudio de LCR del 19/01 con gram y cultivo (-).

3a) Desde el punto de vista de conciencia: evoluciona con fluctuación cuali-cuantitativa, predominando delirium hiperactivo requiriendo tratamiento con neurolepticos y Dexmedetomidina. El 24/01 evaluado por neurología por periodos paroxísticos de taquicardia y agitación psicomotora, a quien no impresiona clínica categórica de síndrome convulsivo, sin poder descartar que clínica corresponda a actividad simpática paroxística o delirium hiperactivo.

4) Renal: Sin alteración función, evoluciona durante estadía con alteraciones leve hidroelectrolíticas resueltas tras cargas. Inicia Colistín (22/01) con vigilancia de diuresis (riesgo de poliuria) y control hidroelectrolítico y renal

5) Infeccioso: Al ingreso a UPC sospecha de NAC aspirativa, se inicia Ampicilina/Sulbactam empírico. CAET 02/01 E. Cloacae R Ampi/Sulb. por lo que se ajusta esquema antibiótico a Tazonam. Evoluciona con alza significativa de PPII. Se pancultiva y se escala a Meropenem + Vancomicina en dosis meníngeas. Evoluciona con PPII elevados, estacionarios y estado febril-subfebril, se ajusta antibioterapia: Se suspende vancomicina, se suspende carbapenémico y se pasa a Tazonam.

- 10/01 con nuevo peak, se pancultiva y se escala a Vancomicina/Imipenem. Se rescatan HC 2 (+) S. epidermidis y pasteuri a las 17 horas de incubación, completando 7 días de tratamiento.

- 18/01 nuevo peak febril y elevación de PPII, se toman nuevos cultivos con estudio de LCR levemente inflamatorio pero Gram y cultivo (-). Se rescata CAET (+) para K. pneumoniae BLEE resistente a carbapenémicos con S para colistín (FI 22/01/2023), completa 7 días y HC I (-) y II (+) para S. epidermis a las 27 hrs por el cual recibió 3 días de vancomicina con suspensión precoz dado que se interpreta como contaminación.

Se decide traslado a UTINcx para continuar rehabilitación.

Evolución durante Hospitalización en UTIN CX y Sala:

1) Hemodinamia: Paciente cursa con taquicardia autolimitada, Angio TAC de tórax, sin evidencia de TEP. Resuelve con volemicación.

- A posterior con fluctuaciones de FC, HTA y temperatura, impresionan en contexto de disautonomía por compromiso de SNC. En manejo sintomático, con BIC de Ketoprofeno y Metamizol, Paracetamol y medidas físicas para manejo de fiebre, conflicto principal. Dado pronóstico omoso, se solicita sólo monitorizar, sin control de signos vitales

Con necesidad de uso continuo de AINEs, sin falla renal previa pero con alto riesgo de desarrollo/riesgo de hemorragia

**Fecha Epicrisis : 04/03/2023 11:31**

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 11:31:42

Página 3 de 4

digestiva, se asume en pos de beneficio de manejo de fiebre.

El fin de semana con descompensación desde su basal, FC 170 lpm, fiebre hasta 39.5°C, tersianas. Se decide con familiares sedación paliativa, pero, en contexto de mejoría HDN y de estado, y somnolencia, se desestima.

2) Neurológico/Neuroquirúrgico: Paciente ingresó a unidad en estado vigil sin respuesta (vegetativo), con DVE instalado con disminución progresiva de débitos. Se inició prueba de cierre, siendo tolerada el día 29/01, por lo que se decide retiro de DVE. TAC de control sin complicaciones. Sin otras complicaciones neurológicas, se define en conjunto con equipo que paciente no sería candidato a nueva intervención neuroquirúrgica; familia informada al respecto, de acuerdo con adecuación de esfuerzo terapéutico por mal pronóstico neurológico.

- Con evaluación formal por neurología para sello formal de pronóstico, requiere rehabilitación intensiva, pero con funcionalidad anticipada de dependencia total, por lo que se mantiene manejo actual

3) Infeccioso: Paciente ingresó con tratamiento con colistín por traqueítis con CAET (+) para K. pneumoniae BLEE resistente a carbapenémicos (sin carbapenemasas detectadas), con buena respuesta, completando 7 días de tratamiento.

El 29/01 paciente cursó con peak febril, se tomaron cultivos y se inició amikacina por orina inflamatoria. Pos teriormente con presencia de KPN BLEE en cultivo de a s pir a do traqueal, por lo que se agregó amikacina, completando 5 días de tratamiento en nebulización y 10 días de amikacina EV. Persiste febril, en manejo sintomático

4) Gastroenterológico: Se inicia PEG por constipación, con necesidad de aumento de dosis para lograr respuesta

5) Fonoaudiológico: Trastorno de deglución FILS 3, no rehabilitable. Se realiza GTT 13/02/23, sin incidentes

6) Profilaxis: Se mantiene con profilaxis de LPP y tromboprofilaxis. Actualmente con LPP sacra, en manejo con curaciones por equipo de enfermería.

Paciente con mal pronóstico, en mal estado, explicado y conversado con familia, al tanto.

### Diagnósticos Actuales:

1. HSA Fisher IV WFNS IV aneurismática sacular, con aneurisma C. Anterior

- Fiebre de origen central, de difícil manejo
- Vaciamiento ventricular/HIC frontal izquierdo (27/12)
- Hidrocefalia aguda, resuelta
- Vasoespasmo; angiografía terapéutica 02/01 y 03/01
- Infartos cerebrales múltiples, con comportamiento maligno
- Hipertensión endocraneana, craniectomía descompresiva (06/01)

2. Traqueobronquitis por KPN BLEE

3. Crítico crónico:

- Neuromiopatía del paciente crítico
- TQT, actualmente en filtro
- LPP sacra G III

### Cuadros resueltos en unidades previas:

1. Traqueobronquitis por K.pneumoniae BLEE tratada

2. Sarcopenia severa

3. IAAS

3.1. Bacteriemia por S. epidermidis y pasteuri tratada

3.2. Sepsis a foco respiratorio. E. cloacae tratada

Antecedentes: Policonsumo, PBC y cocaína.

04/03/2023 09:25 HORAS--->se constata ausencia de signos vitales.

Certifico defunción: paciente inconciente, pupilas midriáticas fijas no reactivas, no responde a dolor; sin pulso ni auscultación cardíaca, sin ventilación espontánea.

Monitor con ritmo en asistolia.

Se llama a familiares para informar.

Fecha Epicrisis : 04/03/2023 11:31

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 04-03-2023 11:31:42

Página 4 de 4

### Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda - 1. HSA Fisher IV WFNS IV aneurismática sacular, con aneurisma C. Anterior

- Fiebre de origen central, de difícil manejo
- Vaciamiento ventricular/HIC frontal izquierdo (27/12)
- Hidrocefalia aguda, resuelta
- Vasoespasmo; angiografía terapéutica 02/01 y 03/01
- Infartos cerebrales múltiples, con comportamiento maligno
- Hipertensión endocraneana, craniectomía descompresiva (06/01)

2. Traqueobronquitis por KPN BLEE

3. Crítico crónico:

- Neuromiopatía del paciente crítico
- TQT, actualmente en filtro
- LPP sacra G III

**Condición de Egreso** Fallecido

**Egreso con Catéter Doble J:** NO

FALLECIDO

### Plan Post Alta

FALLECIDO

### Indicaciones

**Tipo de Reposo** :

**Régimen Alimentario** :

**Medicamentos** :

### Controles

INTERNO

Becado/Residente



Ada Cascone Scarpatti

Médico Tratante (Staff)